

导致肾脏供血障碍,引起肾小管坏死^[2]。

4 马兜铃酸肾病的治疗

透析可明显减少木通中毒性肾病的死亡的病例,但肾功能难以恢复。有报道急性或慢性马兜铃酸肾病早期可口服泼尼松 30~40mg·d⁻¹,每 3 个月可减量 10mg,维持治疗 1 年可延缓间质纤维化的进程。本例患者进行血液透析治疗后,病情平稳,但肾功能未能恢复,最后施行了肾移植手术,病情才趋平稳。

本例报道提示,临床医生应认识马兜铃酸致肾

毒性的危害,正确使用龙胆泻肝丸等含马兜铃酸的中成药,为保证临床用药安全,应加强对含马兜铃酸的中草药及其制剂的监测。

参考文献

- 1 Vanherweghem JL, Depierreux M, Tielemans C. *et al.* Rapidly progressive interstitial renal fibrosis in young woman association with slimming regime n including Chinese herbs. *Lancet*, 1993, 341: 387.
- 2 李锋,程庆烁,董柯.对 13 例木通中毒导致急性肾功能衰竭的分析.中国中药杂志,1999,24(7):435.

药物相互作用引起不良反应 4 例

周颖 鲁云兰 (北京大学第一医院,北京 100034)

本文介绍 4 例因药物相互作用引起的不良反应(ADR)病例报告,提请临床注意。其中利福平和异烟肼合用引起肝损害 2 例;西沙必利和西咪替丁合用引起转氨酶升高 1 例;甲氨蝶呤和甲基苄肼合用引起精神障碍 1 例。

1 利福平和异烟肼合用引起肝损害

例 1 女,62 岁,因盆腔结核于 1993 年 5 月 29 日使用乙胺丁醇 0.75g, tid, 异烟肼 0.1g, tid, po 和链霉素 1g, qd, im。治疗 7d 后停用链霉素。检测肝功能:ALT 40U·L⁻¹, AST 37U·L⁻¹。于 7 月 13 日加用利福平 0.15g, tid po。治疗 1 周后,患者出现食欲不振,恶心;2 周后出现眼黄,纳差,大便发白,呕吐,7 月 30 日停用抗结核药物。查体:皮肤、巩膜明显黄染,未见出血点及蜘蛛痣,肝掌(-),肝脾肋下未及。8 月 7 日复查肝功能:ALT 131U·L⁻¹, AST 88U·L⁻¹, T-Bil 234.11 μmol·L⁻¹, D-Bil 226.97 μmol·L⁻¹, 病毒学检查示:甲、乙、丙、戊肝炎病毒均为阴性。B 超示:弥漫性肝病,脾大,无肝外梗阻,胆囊炎。给予甘草酸二铵(强力宁)注射液 80ml qd、门冬氨酸钾镁注射液 20ml bid、葡醛内酯 0.2g qd po、促肝细胞生长素 100mg qd、支链氨基酸 250mg qd、胸腺肽 20mg qd 静滴等治疗。但病情继续恶化,黄疸加深。复查肝功能:T-Bil 577.82 μmol·L⁻¹, D-Bil 298.35 μmol·L⁻¹, 既而出现肾功能衰竭,UREA: 27.22mmol·L⁻¹, Cr 209.5 μmol·L⁻¹。虽积极抢救,终因急性肾功能衰竭和腹腔感染伴感染性休克死亡。

例 2 男,45 岁,因结核性胸膜炎于 1999 年 12

月 18 日起口服利福平 0.15g, tid、异烟肼 0.3g, qd, 和吡嗪酰胺治疗。服用 3 月后出现乏力、纳差、厌油、恶心、呕吐,随后出现皮肤、巩膜黄染并逐渐加重,小便色黄。查体:慢性病容,皮肤巩膜明显黄染,未见出血点及蜘蛛痣,肝掌(-),肝脾肋下未及。检测肝功能:ALT 468U·L⁻¹, AST 332U·L⁻¹, T-Bil 337.52 μmol·L⁻¹, D-Bil 210.41 μmol·L⁻¹, 病毒学检查示:甲、乙、丙、戊肝炎病毒为阴性。B 超示:弥漫性肝病,胆囊炎。停药并予以强力宁注射液 80ml qd,茵栀黄注射液 100ml qd,促肝细胞生长素 100mg qd 静滴治疗,2 个月后患者肝功能恢复正常。

2 西沙必利和西咪替丁合用引起转氨酶升高 1 例

例 3 男,78 岁,因胃部不适于 1996 年 4 月 1 日口服西沙必利(普瑞博思) 5mg, tid 和西咪替丁 0.4g, tid 治疗。1 月后,患者自觉乏力,纳差,腹胀,尿黄。查体:巩膜无黄染,肝脾不大。检测肝功能:ALT 124U·L⁻¹, AST 99U·L⁻¹, 病毒学检查示:甲、乙、丙、戊肝炎病毒为阴性。诊断为药物性肝炎。停药并予以复方益肝灵 0.5g, tid; 维生素 C 0.2g, tid; 复合维生素 B₂片, tid po 治疗。1 月后查肝功能恢复正常。

3 甲氨蝶呤和丙卡巴肼合用引起精神障碍 1 例

例 4 男,52 岁,因非霍奇金急性淋巴瘤于 1998 年 9 月 7 日起静滴甲氨蝶呤 10mg, 隔日一次,口服丙卡巴肼(甲基苄肼)胶囊每日 100mg 治疗。6d 后患者出现精神障碍。表现为烦躁,躁动,谵语,反应迟钝。同时出现一过性运动障碍:四肢运动障碍,行走

困难。经停药及对症治疗,3d 后好转,7d 后症状消失。

讨论 例 1、例 2 均为利福平和异烟肼合用,使药物的肝毒性增强,转氨酶和胆红素水平升高。现在一般主张两药联合作为肺结核治疗的早期用药,虽然不能因两药潜在的相互不良作用而禁止联用,但在联用时应定期检查肝功能,若发现肝损害则应停用一种药或两药同时停用。西咪替丁可增加西沙必利的血浆浓度和药理作用。而西沙必利可降低西

咪替丁的血浆浓度和药理作用。这是因为西咪替丁可抑制西沙必利的肝脏代谢。西沙必利可降低西咪替丁的口服生物利用度。但这种相互作用的药代动力学变化和临床意义尚不明确。在药物不良反应中,有相当一部分是由于药物相互作用引起。如近期 FDA 采取措施的几种药物:西力伐他汀、阿司咪唑等。因此,减少用药种类,开展 ADR 监测已成为安全、有效用药的必要措施。

胰激肽原酶致重症多形红斑药疹

赵艳霞 李东明 王云 陈学荣 (北京大学第三医院, 北京 100083)

重症多形红斑 (Stevens-Johnson syndrome), 是一种严重的大疱性多形性红斑,伴有严重的全身性反应,如畏寒、高热、脓毒血症等。并有眼、口、生殖器粘膜损害,患者以儿童多见,病程为 4 周左右,在未用激素以前,其死亡率曾达 30%。呼吸道损害可引起支气管炎、肺炎及胸腔积液,肾损害可能严重,眼损害可导致失明,多由磺胺和巴比妥制剂引起。最近皮肤科病房收入 1 例由胰激肽原酶引起的重症多形红斑型药疹,现报告如下。

患者女,61 岁,因高血脂于 2002 年 3 月 5 日 8:30am 在当地医院遵医嘱加服胰激肽原酶(怡开)240 万 U 治疗。下午再次服该药 120 万 U。当晚 7 时左右,患者大腿内侧,背部出现水肿性红色斑丘疹,伴有发热,当时未予重视。次日清晨,上述皮损弥漫至颜面和全身,背部皮疹融合成片,伴上眼睑浮肿,眼结膜充血,睁眼困难,羞明流泪,自觉口腔苦涩难忍。测体温为 39.7℃,当地医院给予氯苯那敏 4mg,泼尼松 10mg po。服后未见好转,于 3 月 7 日以“重症多形红斑型药疹”收入我院。患者既往无食物和药物过敏史,曾服肠溶阿司匹林 3 片 qd,吉非贝齐 2 片 bid 治疗 2 年。

入院查体:T 39.4℃, P 86 次·min⁻¹, R 18 次·min⁻¹, BP 110/65mmHg,精神差,心肺(-),腹部检查无阳性发现。皮科情况:颜面、四肢躯干密集水肿性红色圆形与不规则形斑丘疹,部分丘疹红斑边缘带紫色,少数皮疹呈同心圆形扩大,中心呈暗紫红色、中央无水疱,某些皮疹融合成片,压之褪色,双眼睑红斑,浮肿,双结膜充血,口腔、外阴粘膜见散

在的大小不一红色斑块,少数糜烂,四肢关节活动灵活无疼痛。化验检查:血常规:WBC $5.4 \times 10^9 \cdot L^{-1}$, N 0.77, L 0.23, RBC $3.97 \times 10^{12} \cdot L^{-1}$, HGB $116g \cdot L^{-1}$, PLT $188 \times 10^9 \cdot L^{-1}$, ESR 27mm·h⁻¹。血脂检查:HDL-C $0.76mmol \cdot L^{-1}$,载脂蛋白 (APoA) $99.8mg \cdot dL^{-1}$, TG $2.29mmol \cdot L^{-1}$,余未见异常。

入院后诊断为药疹(重症多形红斑型),给甲泼尼龙 60mg 加入 5%葡萄糖注射液 250ml 静滴 qd,丙种球蛋白 10g,左氧氟沙星 200mg 静滴 qd,葡醛内酯 0.6g 和维生素 C 3.0 加入 5%葡萄糖注射液 500ml 静滴 qd。连用 3d 后病情稳定,停用丙种球蛋白,甲泼尼龙减为 40mg 静滴。继续治疗 3d 后,患者皮疹色泽明显变淡,甲泼尼龙改为泼尼松 40mg po,以后渐渐减量,治疗 10 余天后患者痊愈出院。

讨论 怡开为胰激肽原酶的肠溶片剂。胰激肽原酶 (Pancreatic Kininogenase) 又称胰激肽释放酶 (Pancreatic Kallikrein), 系内切蛋白水解酶类,分子量 26800。胰激肽原酶在体内作用于激肽原释放出激肽,从而产生一系列药物效应,如舒张毛细血管、扩张小动脉、促进前列腺素分泌、改善各器官血流、降低血粘度、防止血栓形成等。临床上适用于各种因微血管循环障碍所致疾病的治疗。本品不良反应轻微,适宜长期服用,但此药属于大分子类药物,同时具有免疫原性与反应原性,可作为完全抗原与相应抗体发生特异性结合,从而引起变态反应。而 Stevens-Johnson 型药疹亦属于药源性皮肤病中药物变态反应的类型。患者发生上述反应时同时服药物有阿司匹林和吉非贝齐,此两种药物都属于小分